

1. Introducción y relevancia clínica

Los **cuerpos extraños de la vía aérea (CEVA)** constituyen una **emergencia vital frecuente**, especialmente en **niños menores de 5 años**, que pueden producir desde disfonía leve hasta **asfixia aguda y muerte**.

Cuando el objeto se aloja en la **laringe o la tráquea**, compromete directamente la vía respiratoria, provocando **obstrucción parcial o total**.

Epidemiología

- **Incidencia máxima:** entre 1 y 3 años de edad.
- En Chile, es una de las **principales causas de muerte accidental en menores de 4 años**.
- Más frecuente en:
 - Niños pequeños (por exploración oral).
 - Adultos mayores con prótesis dentales.
 - Pacientes neurológicos o con alteración de la deglución.

Relevancia clínica

- Urgencia que requiere **reconocimiento inmediato** y manejo rápido.
 - Puede confundirse con **crup, asma o laringitis**, retrasando el diagnóstico.
 - En el EUNACOM, se evalúan:
 - **Diagnóstico clínico precoz.**
 - **Maniobras iniciales de desobstrucción.**
 - **Derivación a manejo especializado.**
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo de aspiración

La aspiración ocurre cuando un cuerpo extraño (alimento, pieza plástica, objeto pequeño) **pasa inadvertidamente la glotis** y queda impactado en la **laringe o tráquea**, causando distintos grados de obstrucción.

El grado de obstrucción determina la urgencia:

- **Obstrucción total:** imposibilidad de hablar o toser, cianosis rápida → **asfixia en minutos**.
- **Obstrucción parcial:** tos, estridor, disfonía, dificultad respiratoria progresiva.

2.2 Localización más frecuente

Sitio	Frecuencia	Manifestaciones típicas
Bronquio principal derecho	60–70%	Tos persistente, sibilancias unilaterales.
Tráquea	10–20%	Estridor bifásico, tos metálica.
Laringe	5–10%	Disfonía, afonía, estridor inspiratorio o asfixia súbita.

2.3 Tipos de cuerpos extraños

- **Orgánicos:** semillas, frutos secos (causan inflamación intensa).
- **Inorgánicos:** piezas plásticas, metales, alfileres, juguetes.
- **Dentales:** prótesis o coronas (adultos mayores o postoperatorios).

- Los **cuerpos orgánicos** pueden causar reacción inflamatoria, edema y formación de granulomas si no se extraen precozmente.
-

2.4 Fisiopatología de la obstrucción

- En **laringe**, el cuerpo impacta entre las cuerdas vocales → **disfonía súbita, tos y estridor inspiratorio**.
 - En **tráquea**, puede moverse con la respiración → **ruido metálico o “click traqueal”**.
 - Si pasa al bronquio, puede causar **atelectasia o infección secundaria**.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Cuadro clínico típico

- **Inicio súbito** tras episodio de juego o comida.
 - **Crisis de tos intensa y disnea**.
 - **Estridor inspiratorio** (laringe) o **bifásico** (tráquea).
 - **Disfonía o afonía brusca**.
 - **Signos de obstrucción parcial o total:**
 - Tiraje intercostal, uso de músculos accesorios.
 - Cianosis o hipoxia.
 - Tos inefectiva o silencio respiratorio.
-

3.2 Evolución en fases

1. **Fase aguda:** tos, ahogo, disnea.
2. **Fase de aparente mejoría:** tos leve o disfonía persistente.

3. **Fase de complicación:** neumonía, atelectasia o absceso pulmonar si no se diagnostica.
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Crup viral (laringitis)	Progresivo, febril, tos perruna, no inicio súbito.
Epiglotitis	Fiebre alta, sialorrea, sin tos.
Asma / broncoespasmo	Historia previa, sibilancias difusas.
Reacción alérgica / anafilaxia	Urticaria, edema facial, exposición a alérgeno.
Parálisis de cuerda vocal	Disfonía progresiva, sin episodio de aspiración.
Inicio súbito durante alimentación o juego → pensar primero en cuerpo extraño.	

3.4 Examen físico

- **Paciente ansioso, tosiendo o cianótico.**
 - **Disfonía o afonía.**
 - **Estridor inspiratorio (laringe) o bifásico (tráquea).**
 - **Ausencia de murmullo vesicular** si obstrucción baja.
 - En casos graves: **silencio respiratorio y pérdida de conciencia.**
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **clínico en la fase aguda**, basado en:

- Episodio súbito de asfixia o tos.
 - Síntomas respiratorios persistentes posteriores.
 - Signos de obstrucción de la vía aérea superior.
-

4.2 Exámenes en casos no urgentes

Examen	Hallazgos
Radiografía de cuello y tórax (PA y lateral)	Puede mostrar objeto radiopaco o hiperinsuflación unilateral (válvula).
Tomografía computarizada	En casos atípicos o crónicos, muestra localización exacta.
Laringoscopia directa o broncoscopia rígida (diagnóstica y terapéutica)	Examen de elección para confirmar y extraer el cuerpo extraño.
En niños, la radiografía normal no excluye cuerpo extraño , ya que muchos son radiolúcidos (plástico, maní, semillas).	

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Manejo inicial: fase prehospitalaria o en APS

Objetivo: mantener la oxigenación y remover el cuerpo extraño si hay obstrucción total.

A. Si el paciente tose y ventila:

- **No intervenir bruscamente.**
 - Animar a toser.
 - Oxígeno suplementario.
 - Evitar maniobras invasivas que puedan empeorar la obstrucción.
-

B. Si el paciente NO ventila (obstrucción total):

1. Maniobra de Heimlich (compresión abdominal):

- **Adultos y niños >1 año:**
 - Posicionar detrás del paciente.
 - Rodear el abdomen con ambos brazos.
 - Comprimir firme y rápido hacia arriba (5 veces).
 - Repetir hasta expulsión o pérdida de conciencia.
- **Lactantes <1 año:**
 - 5 palmadas interescapulares alternadas con 5 compresiones torácicas (en el esternón).

2. Si pierde conciencia:

- Iniciar **RCP (30:2)**.
 - Revisar cavidad oral solo si cuerpo visible.
-

5.2 Manejo hospitalario (urgencia secundaria o terciaria)

A. Paciente con obstrucción parcial o sospecha persistente:

- Monitorización cardiorrespiratoria.
- Oxigenoterapia con FiO₂ alta.

- No intentar extracción manual sin visión directa.
- Preparar para **laringoscopia o broncoscopia rígida** bajo anestesia general.

B. Extracción definitiva:

- **Laringoscopia directa:** si objeto en laringe.
- **Broncoscopia rígida:** si objeto en tráquea o bronquios.
 - Permite extracción y aspiración simultánea.
- Posterior **broncoscopia de control** para descartar restos o edema residual.

C. Medicación complementaria:

- **Corticoides IV (dexametasona 0,15 mg/kg)** → previene edema postextracción.
 - **Antibióticos profilácticos** si objeto orgánico o lesión mucosa.
 - **Broncodilatadores** si hay broncoespasmo secundario.
-

5.3 Observación posterior

- Control en observación 12–24 horas post extracción.
 - Control radiológico y ORL al alta.
 - Educación a cuidadores (prevención, alimentos seguros, supervisión).
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones agudas

- **Asfixia y muerte súbita** (si diagnóstico o manejo tardío).
- **Edema laríngeo o traqueal.**
- **Neumonía aspirativa.**

- **Broncoespasmo o hipoxemia persistente.**

6.2 Complicaciones tardías

- **Estenosis subglótica o traqueal.**
- **Granulomas o sinequias.**
- **Infecciones respiratorias recurrentes.**
- **Secuelas neurológicas por hipoxia cerebral.**

6.3 Pronóstico

- Excelente si extracción precoz y manejo adecuado.
 - Mortalidad <1% en centros especializados.
 - Peor pronóstico en lactantes y si hubo paro cardiorrespiratorio prolongado.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Inicio súbito** de tos, disfonía o estridor → sospechar **cuerpo extraño** hasta demostrar lo contrario.
 2. En **niños que hablan o tosen**, no realizar maniobra de Heimlich.
 3. **Obstrucción total = emergencia vital** → **Heimlich inmediato**.
 4. **Radiografía normal no excluye diagnóstico.**
 5. **Broncoscopía rígida** es el **método diagnóstico y terapéutico de elección**.
 6. **Laringoscopia directa** en objetos laríngeos visibles.
 7. Siempre **observar postextracción** por riesgo de edema o complicación.
-

Errores comunes

- No sospechar cuerpo extraño en niños sin fiebre con tos persistente.
 - Intentar extracción manual a ciegas (riesgo de empuje más profundo).
 - Administrar sedantes antes de asegurar vía aérea.
 - Omitir broncoscopía de control tras extracción.
 - No indicar observación post procedimiento.
 - Tratar como asma o laringitis sin antecedentes claros de aspiración.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Cuerpo extraño laríngeo o traqueal = urgencia vital.**
2. **Inicio súbito de tos, disfonía o estridor** sugiere aspiración.
3. En **obstrucción total**, aplicar **maniobra de Heimlich** inmediata.
4. **Diagnóstico clínico + confirmación por broncoscopía rígida.**
5. **No realizar extracción manual sin visión directa.**
6. **Corticoides y antibióticos** pueden ser útiles tras extracción.
7. Pronóstico excelente si manejo precoz; prevención es clave.